

注射, bid, 连用 5~7d, 治疗 5 例腮腺炎并发脑炎患儿, 脑膜刺激征均在 4d 内消失, 2 例偏瘫者分别在 5d, 13d 肌力恢复正常^[11]。

9 治疗难治性肾病

对 6 例经正规激素及 CTX 治疗无效的难治性肾病患者, 用 TH 及干扰素治疗后, 尿蛋白均在 8 周内消失, 尿爱迪氏计数在 16~30 周内完全正常, 随访 1 年无异常。方法: 每次干扰素 15 万 u, TH 10mg, 隔天一次, 1 月后改每周 2 次, 3 月后改每周一次, 共用 6 个月^[12]。机理与调节免疫有关。

参考文献

1 戴仲东, 卢 竞, 张梓荆等. 胸腺肽治疗反复呼吸道感染的研究. 中华儿科杂志, 1993, 31(6) : 353
2 冯益真, 孙秀荣, 崔振方等. 免疫调节剂治疗哮喘病临床与免疫功能效果观察. 中华儿科杂志, 1994, 32(2) : 99
3 姬树鹏. 小牛胸腺素结合中医辨证防治小儿支气管哮喘临床观察. 中西医结合杂志, 1991, 11(8) : 492

4 陈育智, 韩秀兰, 聂 明等. 胸腺肽治疗儿童支气管哮喘及喘息性支气管炎的疗效观察. 中华结核和呼吸系统疾病杂志, 1986, 9(4) : 211
5 沈永学, 郭玉铭. 胸腺肽与维生素 K₃ 治疗婴幼儿喘息性肺炎 50 例报告. 医师进修杂志, 1991, 14(3) : 14
6 芳祖佑, 曹容珍, 孙兰珠. 小儿心肌炎免疫功能变化及胸腺素疗效观察. 临床儿科杂志, 1990, 8(6) : 383
7 汪风兰. 胸腺素治疗儿童再生障碍性贫血疗效观察. 实用儿科临床杂志, 1990, 5(4) : 191
8 郑君仪. 胸腺肽治疗组织细胞增生症. 广东医学, 1991, 12(2) : 51
9 李学真, 杨正泉, 李桔花等. 胸腺肽治疗过敏性紫癜的临床观察. 铁道医学, 1993, 21(3) : 133
10 祁岩超, 卜 夏, 王燕芳等. 细胞刺激因子和胸腺素治疗小儿乙肝 50 例疗效分析. 临床医学, 1991, 11(6) : 241
11 李广宪. 人胎胸腺素和神经生长因子治疗腮腺炎并发脑膜炎 5 例. 实用儿科临床杂志, 1992, 7(1) : 55
12 徐树东, 宋芝萍, 孔庆璇等. 干扰素、胸腺肽治疗难治性肾病 6 例报告. 临床儿科杂志, 1996, 14(1) : 67

(1997 年 3 月 23 日收稿)

环孢素 A 与其它药物相互作用

胡中慧 (兰州军区乌鲁木齐总医院 乌鲁木齐 830000)

环孢素 A(Cyclosporin A, CsA) 是一种新型强效免疫抑制剂, 目前是对抗肾、肝、心、胰脏及骨髓等器官和组织同种异体移植时的首选药^[1]。CsA 还用于很多身体免疫疾病。其中尤以胰岛素依赖性糖尿病、银屑病和类风湿性关节炎等。随着临床应用的扩展, 发现该药可与很多药物发生相互作用, 现分述如下。

1 与糖皮质激素

CsA 为药酶抑制剂, 能降低糖皮质激素的代谢, 增强其疗效; 糖皮质激素也是药酶抑制剂, 大剂量氢化泼尼松可降低 CsA 的代谢, 减少清除率, 增高 CsA 的血浓度。但 CsA 与大量糖皮质激素如甲基氢化泼尼松等合用, 可引起癫痫发作。

2 与已知有肾毒性作用的药物

CsA 的主要毒性反应为肾功能损害, 它与氨基糖苷类、两性霉素 B、环丙沙星、美法仑、甲氧苄胺嘧啶等合用时, 可增强肾毒性, 严重可引起可逆性肾功能衰竭。由于单用非甾体类抗炎

药可对肾功能产生不良影响, 故当它们开始与 CsA 合用时, 应严密地监测肾功能。CsA 与苯丙氨酸氮芥、溶肉溜素合用可增加肾曲小管损害, 加重肾毒性。

3 提高 CsA 血浆或全血浓度的药物^[2~4]

许多药物通过竞争性抑制或诱导有关 CsA 代谢和排泄方面的肝酶, 特别是细胞色素 P₄₅₀, 从而提高或降低血浆或全血的 CsA 浓度。克霉唑、酮康唑、西咪替丁、雷尼替丁、红霉素和交沙霉素等大环内酯类抗生素, 强力霉素、口服避孕药, 苯丙酮以及包括硫氮 酮、尼卡地平和维拉帕米等在内的某些钙通道阻滞剂, 它们能抑制肝脏细胞色素 P₄₅₀ 酶系, 使 CsA 代谢受抑制, 清除率下降, 血药浓度及血清肌肝浓度升高。故它们合用可显著增加 CsA 的免疫抑制作用和毒性。甲氧氯普胺可加速胃排空速度, 而 CsA 主要在小肠吸收, 两药合用时, 可增加 CsA 的吸收率, 使全血浓度增高, 达峰时间提前。

4 降低 CsA 血浆和全血浓度的药物

苯巴比妥、苯妥英钠、卡马西平、西司他丁 (Cilastatin)、酰胺咪嗪等均为强药酶诱导剂,可加速 CsA 的代谢和清除,使其血药浓度下降。磺胺二甲嘧啶(非口服剂)、甲氧苄胺嘧啶、复方磺胺甲噁唑、利福平、异烟肼均能促进 CsA 肝内代谢,合用可显著降低 CsA 的血浓度。

5 与其它药物

CsA 可增加洛伐他汀和秋水仙碱对肌肉的潜在副作用,从而引起肌肉疼痛和肌无力。硝苯地平有纠正 CsA 所致的血流动力学异常和保护肾脏作用,可减轻 CsA 的毒副反应。但硝苯地平可引起齿龈增生,故两药合用可增加齿龈增生的发生率。CsA 是免疫抑制剂,一般除皮质激素外,不应与其它免疫抑制剂合用,但为降低 CsA 引起的肾功能障碍或肾脏结构改

变,与硫唑嘌呤合用。但长期使用硫唑嘌呤会增加感染机会及产生淋巴瘤的可能性。由于 CsA 可抑制肾脏排泄尿酸,能引起高血钾或加重存在的高血钾症,合用氢氯噻嗪、呋喃苯胺酸等利尿药后,可使肾小管重吸收尿酸增加,易诱发痛风发作。CsA 能使地高辛的血浆清除率和体内分布容积减少,肌肝清除率降低,血药浓度上升,易出现地高辛积蓄中毒。

参考文献

- 1 王肾才,王众梧,廖有谋等主译.临床药物大典·第1版·山东济南出版社.1995;1458~1460
- 2 孙成春,郝俊文,李香铁等.影响环孢菌素 A 血药浓度的因素分析.现代应用药学.1995,12(2):37
- 3 Lindholm A. Factors influencing the pharmacokinetics of cyclosporine in man. Ther Drug Monit, 1991, 13(6):465
- 4 徐达,范军,谢桐等.酮康唑对环孢菌素 A 血药浓度的影响.中华器官移植杂志,1993,14(1):12

(1997年5月21日收稿)

不同剂量两种给药方法的米索前列醇用于孕晚期引产的临床效果比较

刘正平 李丛梅 胡晓萍 郎雁 陈绯 张娟

(中国人民解放军第161中心医院 武汉 430010)

黄燕萍 (武汉市第六医院)

米索前列醇 (Misoprostol) 用于促宫颈成熟及引产多为阴道给药,用药剂量各家报道差异较大^[1,2],因而探讨合理、安全的用药方案尤显重要。本文试以不同剂量两种给药方式应用米索前列醇促宫颈成熟及引产,以探讨本给药方法的临床效果和安全性。

1 资料和方法

1.1 研究对象 1996年10月至1997年11月住院待产的足月初产妇148名,符合以下条件者予以引产:单胎、头位、改良 Bishop 评分 ≤ 4 分,每小时自发性宫缩 < 4 次,且有引产指征者。而先露异常、胎儿窘迫、产前异常出血、头盆不称者除外。随机分组给药,口服给药组51例,阴道给药50 μg 组(I组)46例,阴道给药100 μg 组(II组)49例。三组孕妇年龄、孕龄、孕次无差异。引产指征多为延期或过期妊娠、妊高征、羊

水过少、胎膜早破等。

1.2 给药方法 米索前列醇为英国 Searle 药厂生产,每片200 μg 。口服给药组为早晨空腹顿服米索前列醇100 μg ,阴道给药组为早晨置药于后穹窿正中。如给药12h内未正式临产,再重复给药,最多给药3次。

1.3 观察指标 用药至有效宫缩出现的时间、至分娩的时间、胎心及宫缩变化、羊水性状、分娩方式、新生儿体重、Apgar 评分及并发症。用药后24h内经阴道分娩者为引产成功。

1.4 统计学处理 采用方差分析及 χ^2 检验。

2 结果

2.1 引产的临床效果(见表1)

2.2 分娩方式(见表2)

2.3 分娩期并发症及分娩结局(见表3)

3 讨论